COMARCA DE CABO FRIO
1° VARA CÍVEL

PROCESSO nº 0802397-87.2025.8.19.0011

AUTOR: ANGELICA DO NASCIMENTO BARROSO

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por ANGÉLICA DO NASCIMENTO BARROSO em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, objetivando a condenação da ré à cobertura integral de tratamento oncológico, incluindo procedimentos cirúrgicos, medicamentos, materiais (OPME), honorários médicos e internação hospitalar, bem como indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura.

A parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde administrado pela ré desde 1997, tendo sido diagnosticada com câncer no intestino em 2022 e, posteriormente, com câncer no útero e ovários, necessitando de tratamento cirúrgico e quimioterápico, conforme prescrição médica. Relata que teve parte dos procedimentos, materiais e medicamentos negados sob a alegação de ausência de cobertura contratual, por se tratar de plano antigo. Afirma que a negativa é abusiva, colocando em risco sua saúde e vida, razão pela qual requereu tutela de urgência, confirmada liminarmente, e, no mérito, a condenação da ré à cobertura integral do tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais [ID174193668].

A ré apresentou contestação, alegando, em preliminar, a necessidade de correção do valor da causa, por entender que o montante atribuído não corresponde ao real proveito econômico perseguido. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Lei nº 9.656/98 ao contrato da autora, por se tratar de plano coletivo de autogestão firmado antes da vigência da referida lei, defendendo a legalidade das negativas de cobertura, por ausência de previsão contratual e respaldo em parecer de junta médica. Impugna, ainda, o pedido de indenização por danos morais, por ausência de conduta ilícita e nexo causal [ID180447789].

A parte autora apresentou réplica, rebatendo os argumentos da contestação, defendendo a manutenção do valor da causa, a aplicabilidade do CDC e da Lei nº 9.656/98, a abusividade das negativas de cobertura e a configuração do dano moral [ID188520602].

As partes manifestaram-se sobre a produção de provas, tendo ambas declarado não haver outras a produzir, pugnando pelo julgamento antecipado da lide [ID206739920][ID207866867].

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Da impugnação ao valor da causa

A ré impugna o valor atribuído à causa, alegando que não reflete o real proveito econômico perseguido. Contudo, tratando-se de obrigação de fazer relativa à cobertura de tratamento médico de alta complexidade, com múltiplos procedimentos, materiais, medicamentos e honorários médicos, cujo custo não poderia ser previamente estimado com precisão, mostra-se adequada a adoção de valor estimado, nos termos do art. 292, §3º, do CPC. Ademais, eventual excesso poderá ser corrigido em sede de liquidação de sentença, não havendo indício de má-fé ou abuso na fixação inicial. Rejeito, pois, a impugnação ao valor da causa.

II.2 – Da ausência de relação de consumo e não aplicabilidade do CDC

O artigo 2º, da Resolução nº 137/2006, da ANS, define operadora de autogestão como sendo a pessoa jurídica de direito público ou privado que, diretamente ou por intermédio de entidade pública ou privada patrocinadora, instituidora ou mantenedora, administra plano coletivo de assistência à saúde destinado exclusivamente a pessoas (e seus dependentes) a ela ligadas, por vínculo jurídico ou estatutário, ou aos participantes (e seus dependentes) de associações, fundações, sindicatos e entidades de classes.

Convém ressaltar que existem diferenças sensíveis e marcantes nessa modalidade de operadora de planos de saúde, na qual sobressai a não operacionalização em regime de mercado, a ausência de se auferir lucro e a disponibilização para grupo restrito de pessoas, que também participam de sua gestão.

Embora todas as operadoras celebrem contratos cujo objeto é a assistência privada à saúde, apenas as comerciais operam em regime de mercado, podendo auferir lucro das contribuições vertidas pelos participantes (proveito econômico), não havendo nenhuma imposição legal de participação na gestão dos planos de benefícios ou da própria entidade.

Por conta dessas diferenças, nos contratos de autogestão, verifica-se o respeito aos Princípios do Mutualismo e da Solidariedade, ou seja, os valores alocados ao fundo comum obtidos nas entidades de autogestão pertencem aos participantes e beneficiários do plano, de modo que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus próprios integrantes.

Cumpre reconhecer que tal peculiaridade possibilita a redução dos custos de sua manutenção, cujos serviços são prestados, não mediante contraprestação pecuniária com a finalidade de obtenção de lucro, mas a partir de contribuições dos participantes calculadas, em regra, com base nos seus salários e aposentadorias. Leia-se o posicionamento a respeito do tema, no âmbito do Excelsior Superior Tribunal de Justiça:

REsp: 1285483/ PB - RECURSO ESPECIAL: 2011/0239595-2 – RELATOR: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA SEÇÃO - DATA DO JULGAMENTO: 22/06/2016 - DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/08/2016 – EMENTA -RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.

Por razões dessa ordem, os atos regulamentares da ANS conferem tratamento diferenciado para tais planos de saúde, com a finalidade de atender suas características próprias.

Nesse passo, como as entidades de autogestão não podem oferecer seus planos no mercado de consumo, sob pena de total descaraterização da modalidade, nessa particularidade, enseja a inaplicabilidade das regras do Código Consumerista.

Anote-se ainda, que a edição da Súmula 608, da corte superior, deixou expresso que o CDC não se aplica aos planos de saúde de autogestão. Confira-se:

Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Deste modo, em tais negócios jurídicos, a relação entre a empresa de plano de saúde constituída sob a modalidade de autogestão e os seus filiados é regida pelo Código Civil, observando-se a Teoria Geral dos Contratos, respeitando-se o princípio da força obrigatória do contrato, pacta sunt servanda, bem como o princípio da boa-fé objetiva e seus desdobramentos.

Deste modo, não se aplica ao caso em tela as regras do Código de Defesa do Consumidor.

II.3 – Da obrigação de cobertura do tratamento prescrito

Restou incontroverso nos autos que a autora é portadora de neoplasia maligna, com indicação médica expressa para realização de cirurgia oncológica de alta complexidade, uso de medicamentos específicos (Olaparibe e Bevacizumabe), materiais e equipe especializada, conforme relatórios e orçamentos médicos juntados.

Restou evidente, portanto, que o tratamento necessário à manutenção da saúde da autora tem o caráter de urgência, sendo demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A ré de outro lado, alega que o plano de saúde da autora é anterior à vigência da Lei 9656/98, não adaptado, razão pela qual incide o Tema 123 do STF que exclui a aplicação da nova lei sobre planos de saúde antigos, havendo cláusula expressa que exclui a cobertura dos procedimentos não constantes na Tabela Geral de Auxílios do PLANO.

Dispõe o Tema 123 do STF que:

"As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados."

No caso dos autos, apesar de mencionar na contestação que há cláusula contratual que exclui a cobertura, não apresentou a parte ré o contrato mencionado ou, as condições gerais à época da contratação (a referida tabela mencionada na contestação). Logo, não é possível concluir quanto à exclusão mencionada.

Deve ser observada, ainda, a Súmula 340 do TJRJ, a qual dispõe que *"ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano"*.

Seja como for, ainda que o contrato da autora seja anterior à Lei 9.656/98, não há impedimento de que seja analisado pelo prisma da boa-fé e da vedação de práticas abusivas nos termos do art. 422 do Código Civil. Neste sentido, o seguinte precedente deste E. TJRJ:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE CONTRATADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. AUTOR DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE PRÓSTATA. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO - ZYTIGA (ACETATO DE ABIRATERONA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 948.634, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 123), NO SENTIDO DE QUE "as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os

contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados". PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (STJ REsp 1.285.483/PB). CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO E À LUZ DA BOA-FÉ OBJETIVA. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RÉ DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR O TRATAMENTO DE DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO. (STJ - AgInt no REsp 1887318 / SP). ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE É ABUSIVA A RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DE CUSTEAR A COBERTURA DE MEDICAMENTO DE EFEITO ANTINEOPLÁSICO, REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO DO PACIENTE, AINDA QUE SEJA PARA USO DOMICILIAR (AgInt no REsp n. 2.098.737/PB). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS PELA PORTARIA N. 38/2019 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SAÚDE, APÓS RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO DA CONITEC, PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, E DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SÚMULA 343 DO TJRJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (0096314-68.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO - Julgamento: 09/09/2024 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)))"

A autora, portanto, comprovou sua condição de segurada, a urgência do procedimento e a necessidade dos materiais utilizados, conforme laudo médico.

Destaque-se que o parecer do Junta Médica não é vinculante e não pode obstar a pretensão autoral, por si só, entendimento, inclusive, reconhecido pela Súmula 211 do E. TJRJ dispõe que "*havendo divergência entre o seguro saúde contratado e o profissional responsável pelo procedimento cirúrgico, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha cabe ao médico incumbido de sua realização.*"

Deste modo, a ré não logrou êxito em comprovar a licitude de seu atuar, conforme era seu ônus processual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto ao dano moral, é incidente, na medida em que a situação não configura o mero aborrecimento. A recusa da ré em autorizar os procedimentos, em uma situação de extrema fragilidade do usuário do plano de saúde, na qual havia risco de agravamento de sua saúde, causou, evidentemente, dano extrapatrimonial, eis que lesou a dignidade do consumidor.

Vale destacar os seguintes Enunciados da Súmula deste E. TJRJ, que tratam deste tema:

Súmula nº 337: "*A recusa indevida, pela operadora de planos de saúde, de internação em estado de emergência/urgência gera dano moral in re ipsa."*

Súmula nº. 339: "*A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral."*

Além disso, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nas situações similares, incide o dano moral. Neste sentido:

"Consumidor. Recurso especial. Seguro saúde. Recusa de autorização para a internação de urgência. Prazo de carência. Abusividade da cláusula. Dano moral. Tratando-se de contrato de seguro-saúde sempre haverá a possibilidade de consequências danosas para o segurado, pois este, após a contratação, costuma procurar o serviço já em evidente situação desfavorável de saúde, tanto a física como a psicológica.- Conforme precedentes da 3.ª Turma do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 12/12/2005, p. 374)

Deve assim, ser reconhecida a incidência do dano moral, que deverá ser arbitrado com moderação, sendo suficiente para compensar o consumidor da lesão sofrida, sem, contudo, onerar em demasia a parte ré. Fixo o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC para a) CONVERTER em definitiva a decisão que antecipou a tutela de urgência; b) CONDENAR a ré a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (art. 389, parágrafo único do CC) desde a presente data e juros de mora (art. 406 e seus parágrafos do CC) a contar do evento.

Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma do que dispõe o art. 85, §§1º e 2º do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o montante total da condenação.

Havendo recurso de apelação contra o presente julgado, certifique-se nos autos quanto à tempestividade e preparo. Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões na forma do art. 1.010, §1°, CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação deste e, devidamente certificado nos autos, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça na forma do art. 1.010, §3°, CPC.

Não havendo recurso, certifique-se, dê-se baixa e remeta-se ao arquivo.

Cabo Frio, 16 de janeiro de 2026

JULIANA GONÇALVES FIGUEIRA

Juiz de Direito

Rua Ministro Gama Filho, S/N, Braga, CABO FRIO - RJ - CEP: 28908-090

Assinado eletronicamente por: JULIANA GONCALVES FIGUEIRA
19/01/2026 13:07:00
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

26011913070001600000244143024

IMPRIMIR GERAR PDF